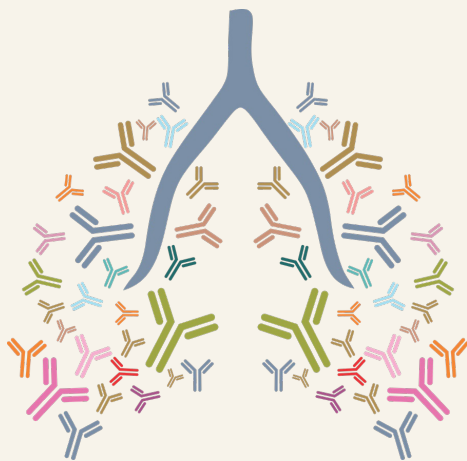




GUIA ILUSTRADO PARA PAIS

Bronquiolite

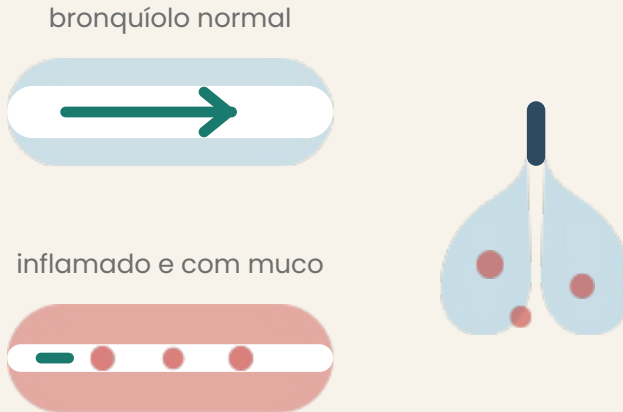
O chiado do bebê, os dias que mais preocupam
e o que realmente funciona

Dra. Ana Karina Fernandes

Pneumologista Pediátrica

CRM/RN 5751 • RQE 6271

O que é a bronquiolite



É o primeiro episódio de chiado no peito causado por uma infecção viral, em **crianças menores de 2 anos** — mais frequente e mais grave **abaixo dos 12 meses**, com pico entre os **3 e os 6 meses de vida**.

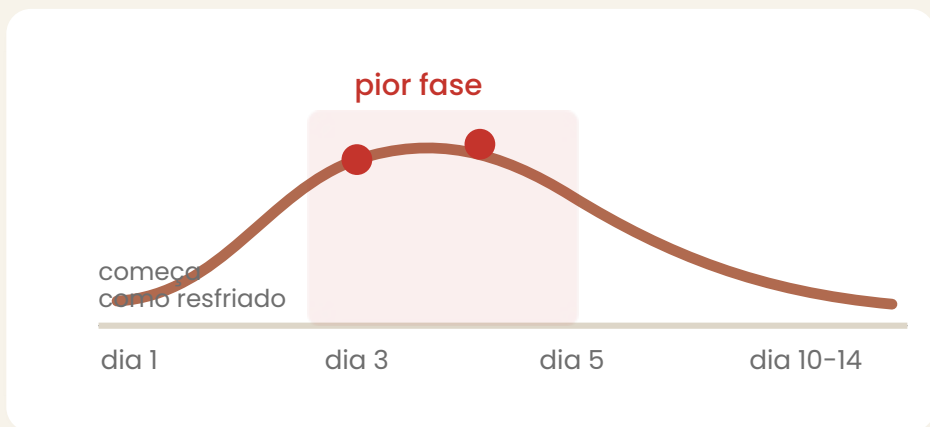
O vírus inflama os **bronquíolos**, os canais mais finos por onde o ar chega aos pulmões. Eles incham e se enchem de muco, e o ar passa com dificuldade. Daí vêm os sinais típicos: **chiado no peito, tosse e respiração mais rápida**.

Quem causa

O **vírus sincicial respiratório (VSR)** responde pela maior parte dos casos. Rinovírus, influenza, metapneumovírus e outros também podem causar. Por ser **viral**, antibiótico não trata bronquiolite.

Como a doença evolui

A bronquiolite começa parecendo um resfriado comum e **piora antes de melhorar**. Entender essa curva evita sustos — e mostra quando redobrar a atenção.



Os dias 3 a 5 são os de maior atenção. É quando o esforço para respirar costuma ser mais intenso. Se a criança foi avaliada no dia 1 e estava bem, ela ainda pode piorar — observe de perto nesse período.

Depois dessa fase, a melhora é gradual. O quadro geral se resolve em **10 a 14 dias**, mas a **tosse pode durar de 3 a 4 semanas** — e isso, sozinho, não significa que algo deu errado.

Resfriado comum ou bronquiolite?

Nos primeiros dias os dois são muito parecidos. A diferença aparece na **evolução** e no **esforço para respirar**.

Resfriado comum

- ✓ Melhora progressiva a partir do 2º ou 3º dia
- ✓ Coriza, espirros e tosse leve
- ✓ Respiração tranquila, sem chiado
- ✓ Mama e bebe normalmente

Bronquiolite

- ! **Piora** entre o 3º e o 5º dia
- ! Tosse intensa e **chiado no peito**
- ! Respiração rápida, com esforço visível
- ! Cansa ou recusa ao mamar

O diagnóstico é clínico: feito pelo exame da criança, sem necessidade de raio-X ou exame de sangue na maioria dos casos.

NÃO ESPERE

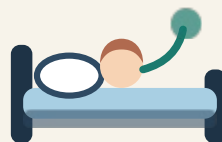
Sinais de alarme

Diante de **qualquer um** destes sinais, leve o bebê para atendimento de urgência imediatamente:

- ! **Esforço para respirar:** afundamento entre ou abaixo das costelas, barriga puxando forte, batimento das asas do nariz
- ! **Gemido** a cada respiração
- ! Respiração muito rápida ou, ao contrário, **pausas na respiração** (apneia)
- ! Lábios, língua ou rosto **arroxeados**
- ! **Recusa de mamadas** ou aceita menos da metade do habitual
- ! Menos fraldas molhadas que o normal (sinal de desidratação)
- ! Bebê **muito prostrado**, largado, ou difícil de acordar
- ! **Menor de 3 meses** com qualquer sinal respiratório ou febre

Em bebês pequenos o quadro pode mudar em poucas horas. Na dúvida entre esperar e levar, **leve**.

Quem tem maior risco de agravar



A maioria dos bebês se recupera em casa. Alguns, porém, merecem vigilância mais próxima desde o início:

- Bebês com **menos de 3 meses**
- **Prematuros**, especialmente os de baixa idade gestacional
- **Cardiopatias congênitas** com repercussão
- **Doença pulmonar crônica** da prematuridade
- **Doenças neurológicas ou neuromusculares**
- **Imunodeficiências** e síndrome de Down
- Baixo peso ou dificuldades de ganho de peso

A internação é indicada quando há necessidade de oxigênio, de hidratação na veia ou por sonda, quando o esforço respiratório é importante, quando há apneia — ou pela própria idade e condição de base do bebê.

Internar não significa que algo foi feito errado: significa que o bebê precisa de um suporte que só o hospital oferece.

Como cuidar em casa

Não existe remédio que encurte a bronquiolite. O tratamento é de **suporte** — e é ele que faz diferença:



Lavagem nasal com soro fisiológico

A medida mais útil em casa. Bebê respira pelo nariz — desobstruir melhora a respiração e a mamada.



Mamadas menores e mais frequentes

Cansa menos. Ofereça peito ou fórmula em maior número de vezes ao dia.



Manter o bebê hidratado

Acompanhe o número de fraldas molhadas: é o termômetro mais confiável em casa.



Controlar a febre se houver

Antitérmico na dose prescrita pelo pediatra, se necessário.



Ambiente livre de fumaça

Fumaça de cigarro piora a inflamação das vias aéreas e prolonga os sintomas.



Observar, observar, observar

Reavalie a respiração várias vezes ao dia, sobretudo entre o 3º e o 5º dia.

Lave o nariz **antes das mamadas e do sono** — é quando mais ajuda.

SEM BENEFÍCIO COMPROVADO

O que não trata a bronquiolite



As diretrizes atuais desaconselham o uso rotineiro destes recursos — eles não mudam o curso da doença e podem trazer efeitos indesejados:



Antibióticos

A causa é viral. Só entram se houver uma infecção bacteriana associada, comprovada pelo médico.



Corticoide oral ou inalatório

Não reduz internação nem encurta a doença na bronquiolite típica.



Broncodilatador de rotina

Não melhora a oxigenação nem o tempo de recuperação. Não deve ser usado por conta própria em casa.



Xaropes para tosse

Não indicados em bebês e crianças pequenas, com risco de efeitos adversos.



Nebulização “preventiva”

Nebulizar sem prescrição não protege o bebê.

Em situações específicas o médico pode testar alguma medicação e avaliar a resposta. O que não se recomenda é o **uso automático**, sem indicação individual.

Como prevenir



O vírus se espalha por gotículas e pelas mãos. Medidas simples reduzem muito o risco, sobretudo nos meses frios:

- ✓ **Lavar as mãos** antes de pegar o bebê — vale para toda a família e visitas
- ✓ **Evitar visitas** de pessoas resfriadas, e beijos no rosto e nas mãos do bebê
- ✓ **Amamentar**, quando possível: reduz risco e gravidade das infecções
- ✓ Casa **livre de fumaça** de cigarro, inclusive no carro e na varanda
- ✓ Adiar a **creche** nos primeiros meses, quando houver essa possibilidade
- ✓ Manter o **calendário vacinal** em dia, incluindo a vacina da gripe a partir dos 6 meses

Se alguém em casa estiver gripado, mantenha distância do bebê, use máscara ao cuidar dele e **lave as mãos antes de cada contato**.

Imunização contra o VSR

Hoje existe proteção específica contra o principal vírus causador da bronquiolite — algo que não estava disponível há poucos anos.



Vacina para a gestante

Aplicada a partir da **28ª semana de gestação**. A mãe produz anticorpos que passam pela placenta e protegem o bebê nos primeiros meses de vida, justamente quando o risco é maior.



Anticorpo para o bebê (nirsevimabe)

Aplicado em **dose única**, protege de imediato por cerca de 6 meses. No SUS é destinado prioritariamente a **prematturos e bebês com condições de risco**; na rede privada, a indicação é mais ampla.

Proteger não é só evitar a doença: é reduzir a chance das formas graves, que levam à internação e ao uso de oxigênio.

As indicações e a oferta na rede pública vêm mudando a cada temporada. **Converse com o pediatra** sobre o que se aplica ao seu filho neste ano.

Quando procurar o pneumologista pediátrico

A maioria dos bebês se recupera completamente e segue com o pediatra. A avaliação do especialista é indicada quando:

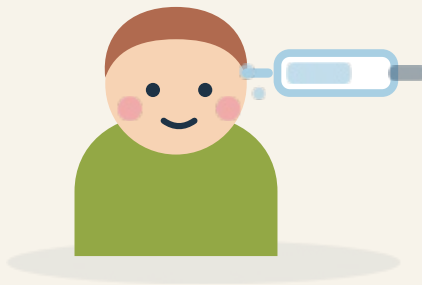
- Chiado que **volta a cada resfriado** nos meses seguintes
- Tosse que persiste **além de 4 semanas**
- **Novas internações** por problema respiratório
- Cansaço para mamar, brincar ou ganhar peso
- Bronquiolite **grave**, com UTI, ventilação ou oxigênio prolongado
- Bebê **premature** ou com doença pulmonar prévia

Por que importa: episódios de chiado repetidos após a bronquiolite podem indicar asma em formação ou outra condição que se beneficia de tratamento. Identificar cedo evita crises, idas ao pronto-socorro e prejuízo ao crescimento do pulmão.

Chiar depois de uma bronquiolite é comum e nem sempre vira asma — mas merece acompanhamento, não silêncio.

Resumo em seis lembretes

- ✓ É **viral**: antibiótico não trata.
- ✓ **Piora entre o 3º e o 5º dia** — vigie de perto.
- ✓ Soro no nariz e mamadas menores ajudam de verdade.
- ✓ Acompanhe as **fraldas molhadas** e a respiração.
- ✓ Esforço para respirar ou recusa de mamada: **vá ao pronto-socorro**.
- ✓ A tosse pode durar **3 a 4 semanas** — é esperado.



Na dúvida, procure o pediatra
que acompanha o seu bebê.



Dra. Ana Karina Fernandes

Pneumologista Pediátrica

CRM/RN 5751

RQE 6271

Este material tem finalidade **educativa** e não substitui a consulta médica, o diagnóstico ou o tratamento indicado para o seu filho.

Conteúdo baseado em diretrizes da Sociedade Brasileira de Pediatria, da Academia Americana de Pediatria, em revisões Cochrane e nas notas técnicas de imunização contra o VSR (SBIm / SBP / FEBRASGO).